



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
IJTIMOIY HIMOYA MILLIY AGENTLIGI DIREKTORINING**

BUYRUG'I

2026-yil 31 - iyul _____

316 -son

**Bolalar uchun xospis markazi to'g'risidagi
vaqtinchalik nizomni tasdiqlash haqida**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-iyundagi PQ-239-son "Aholiga palliativ tibbiy xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq buyuraman:

1. Bolalar uchun xospis markazi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2. Mazkur buyruq O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishilgan.
3. Mazkur buyruq imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi.

Direktor



M.Olloyorov



O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi
direktorining 2026-yil 31-iyul dagi 316son
buyrug'iga
ILOVA

Bolalar uchun xospis markazi to'g'risidagi VAQTINCHALIK NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizom og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bolalar uchun palliativ yordam ko'rsatishga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi (keyingi o'rinlarda – Agentlik) huzuridagi Bolalar uchun xospis markazi (keyingi o'rinlarda – Markaz)ning asosiy vazifalari, faoliyatini tashkil etish, moliyalashtirish va unga bolalarni qabul qilish hamda palliativ yordam ko'rsatish tartibini belgilaydi.

2. Mazkur Nizom 2027-yil 31-dekabrga qadar amal qiladi.

3. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

palliativ yordam – og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bolalarga hamda ularning oila a'zolariga tibbiy, psixologik, ijtimoiy va ma'naviy yordam ko'rsatish orqali bolaning hayot sifatini yaxshilash va og'riqlarni kamaytirishga qaratilgan yordam majmui;

klirik marshrut – bolaga palliativ yordam ko'rsatishning bosqichlari, shu jumladan, uni Markazga joylashtirish yoki mobil shaklda palliativ yordam ko'rsatishga qaratilgan vaqt me'yorlari.

4. Markaz mazkur Nizomning 23-bandida belgilangan talablarga mos keluvchi bolalar (keyingi o'rinlarda – bolalar) uchun palliativ yordam ko'rsatuvchi davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs hisoblanadi.

Markaz o'z shaxsiy g'azna hisobvarag'iga, O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o'z nomi yozilgan muhrga, shtampga hamda blankalarga ega bo'ladi.

5. Agentlik Markazning muassisi hisoblanadi.

6. Markazning rasmiy nomi:

a) davlat tilidagi to'liq nomi – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Bolalar uchun xospis markazi;

b) ingliz tilidagi to'liq nomi – Hospice Center for Children under the National Agency for Social Protection under the President of the Republic of Uzbekistan;

d) rus tilidagi to'liq nomi – Центр детского хосписа при Национальном агентстве социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.

7. Markazning joylashgan joyi (pochta manzili): 100140, Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Amir Temur ko'chasi, 27-uy.

2-bob. Markazning maqsad va vazifalari

8. Markazning asosiy maqsadi og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bemor bolalarning (keyingi o'rinlarda – bemor bolalar) hayot sifatini yaxshilash, ularda kechadigan og'riq va kasallikning boshqa og'ir oqibatlarini yengillashtirishga qaratilgan palliativ yordam ko'rsatishdan iborat.

9. Quyidagilar Markazning asosiy vazifalari hisoblanadi:

bemor bolalarga palliativ yordam ko'rsatish;

bemor bolalarda kechadigan og'riq sindromini boshqarish, jumladan og'riq qoldiruvchi vositalar va maxsus ovqatlanishni tanlash hamda ta'minlash;

bemor bolalarni parvarish qilishni tashkil etish;

bemor bolalarning oila a'zolarini parvarish ko'nikmalariga o'qitish;

bemor bolalar va ularning oila a'zolariga kompleks ijtimoiy va psixologik xizmat ko'rsatish;

bemor bolalarni uy sharoitida parvarish qilish bo'yicha maslahatlar berish;

tunu-kun faoliyat ko'rsatadigan ishonch telefoni ishlashini tashkil etish;

palliativ va xospis yordami sohasida mutaxassislarning malakasini oshirish hamda ularga psixologik xizmatlar ko'rsatish.

Markazga qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalarni ham yuklatilishi mumkin.

3-bob. Markaz faoliyatini tashkil etish va boshqarish

10. Markazni bosh shifokori Agentlik direktori tomonidan Sog'liqni saqlash vaziri bilan kelishilgan holda lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi.

Markaz bosh shifokori bir vaqtning o'zida Samarqand viloyati Bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokorining palliativ yordam bo'yicha o'rinbosari hisoblanadi.

11. Markazni Samarqand viloyatida giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar muomalasi bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi litsenziatlar tomonidan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan ta'minlanadi va ulardan foydalanish belgilangan tartibda qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

12. Bemor bolalarni davolash uchun giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tibbiy ko'rsatmalar va xospis shifokorlarining retsepti asosida tayinlanadi.

13. Markazda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni saqlash, hisobini yuritish, berish va hisobdan chiqarish maxsus jurnallar va dalolatnomalar asosida yuritiladi.

14. Markazda bemor bolalarga palliativ yordam ko'rsatish Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i bilan tasdiqlangan klinik protokollar asosida tashkil etiladi.

Tibbiy faoliyatni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda nazorat qilish, tibbiyot xodimlarining toifasini belgilash va malakasini oshirish, giyohvandlik vositalari hamda psixotrop moddalar saqlanishi ustidan nazorat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.

15. Markaz xodimlarining malakasini oshirish va stajirovka o'tashini tashkil etish maqsadida Rossiya Federatsiyasi va boshqa xorijiy davlatlarga, Toshkent shahar hududlararo xospisiga hamda qonunchilikda belgilangan tartibda boshqa muassasalarga yuboriladi hamda xorijiy mutaxassislar Markazga jalb etiladi. Bunda malaka oshirish bilan bog'liq xarajatlar Ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi.

16. Markazda bemor bolalarning individual qiziqishlari va iqtidorlarini hisobga olib davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari hamda tegishli mutaxassislarni shartnoma asosida jalb etgan holda qo'shimcha to'garak va o'quv kurslari tashkil etilishi mumkin.

Markazda qonunchilikda belgilangan tartibda volontyorlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va diniy tashkilotlar vakillari tomonidan turli tadbirlar va xizmatlar ko'rsatish tashkil etib boriladi.

4-bob. Bemor bolalarni Markazga qabul qilish tartibi

1-§. Palliativ yordamga muhtoj bolalarni aniqlash

17. Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hududida yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan bemor bolalarning qonuniy vakillari palliativ yordam olish yuzasidan tegishli oilaviy poliklinikaga yoki markaziy tuman (shahar) ko'p tarmoqli poliklinikasiga (keyingi o'rinlarda – poliklinika) murojaat qiladi. Oilaviy shifokor bolaning sog'lig'i holatini dastlabki baholaydi, palliativ yordamga ehtiyoj mavjudligini aniqlaydi, zarur tibbiy hujjatlarni rasmiylashtiradi hamda bolaning keyingi klinik marshruti bo'yicha muvofiqlashtirishni amalga oshiradi.

18. Poliklinika tomonidan uch ish kuni ichida bolaning sog'ligi holati tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi va palliativ yordamga muhtojligi pediatrik palliativ skrining (PaPas) shkalasi (keyingi o'rinlarda – shkala) bo'yicha baholashdan o'tkaziladi.

Baholash oilaviy shifokor (yoki palliativ yordam bo'yicha o'qitilgan shifokor) tomonidan PaPas shkalasi asosida amalga oshiriladi. Zaruratga ko'ra tor soha mutaxassislari jalb qilinadi.

19. O'tkazilgan tibbiy tekshiruv va shkala bo'yicha baholash natijalariga ko'ra bolaga mazkur Nizomga 1-ilovada nazarda tutilgan tashxislardan biri qo'yilganda hamda u 15 va undan yuqori ball to'plaganda bolaning qonuniy vakili tanloviga ko'ra poliklinika uni quyidagi tibbiyot muassasalaridan biriga yo'naltiradi:

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va uning filiallari;

Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi;
 Bolalar milliy tibbiyot markazi;
 viloyatlar ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazlari;
 davlat oliy tibbiy ta'lim muassasalarining klinikalari.

Bunda baholash natijalariga ko'ra 14 va undan past ball to'plagan bemor bolalar poliklinika tomonidan tibbiy kuzatuvga olinadi va kasalligi bo'yicha davolash davom ettiriladi.

20. Mazkur Nizomning 19-bandidagi tanlangan tibbiyot muassasasining tibbiy konsiliumi bolaning palliativ yordamga muhtojligi va Markazga joylashtirish uchun yo'llanma berish maqsadga muvofiqligini aniqlash maqsadida bolaga tegishli tibbiy hujjatlar va ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Bunda:

asoslar mavjud bo'lganda bolaga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning XKT-10 (Xalqaro kasalliklar tasnifi, 10-qayta ko'rish)ga muvofiq Z51.5 Palliativ yordam bo'yicha tashxis qo'yadi;

bolaning kelgusidagi klinik marshrutini belgilaydi;

palliativ yordam olish bo'yicha Markazga "E-palliative" axborot tizimi orqali mazkur Nizomning 2-ilovasidagi shaklda elektron yo'llanma beradi.

Oilaviy shifokor tomonidan rasmiylashtirilgan tibbiy hujjatlar, tekshiruv natijalari hamda PaPas shkalasi bo'yicha baholash natijalari Markazga yo'llanma bilan birga taqdim etiladi.

21. Yo'llanmada:

bolaning klinik marshruti va palliativ yordam mobil yoki statsionar shaklda ko'rsatilishi;

mobil shakldagi palliativ yordam ko'rsatish belgilanganda bola uchun zarur jihozlar qayd etiladi.

Yo'llanmaga bolaning kasallik tarixidan ko'chirma ilova qilinishi shart.

Texnik nosozlik sababli "E-palliative" axborot tizimi orqali yo'llanma berish imkoni bo'lmagan hollarda yo'llanma tegishli tibbiyot muassasasi tomonidan yozma shaklda rasmiylashtirilishi mumkin.

2-§. Bemor bolalarni Markazga joylashtirish

22. Markazda bemor bolalarga palliativ yordam ko'rsatishni tashkil etish maqsadida Markaz direktori buyrug'i bilan palliativ yordam bo'yicha shifokor, psixolog va ijtimoiy xodimdan iborat tarkibda Multidissiplinar konsilium (keyingi o'rinlarda – konsilium) tashkil etiladi.

23. Yo'llanmaga ega bo'lgan bola konsilium tomonidan dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va quyidagi mezonlarning barchasiga bir vaqtda muvofiq bo'lganda konsilium palliativ yordam ko'rsatish uchun bolani Markazga qabul qilish to'g'risida qaror qabul qiladi:

a) mazkur Nizomning 19-bandida ko'rsatilgan tibbiyot muassasalari tomonidan Z51.5 Palliativ yordam bo'yicha tashxis qo'yilganda va yo'llanma berilganda;

b) shkala bo'yicha skrining natijasi – 15 va undan yuqori ball bo'lganda;

d) Markaz sharoitida xavfsiz bo'lishi va bemorning tibbiy jihatdan transportirovka qilinishi mumkin bo'lganda.

Mazkur bandning "a" va "b" kichik bandlarida nazarda tutilgan mezonlarga mos bo'lgan bolani Markazga qabul qilish uchun bo'sh o'rinlar mavjud bo'lmaganda yoki uning yo'llanmasida ko'rsatilganda bolaning qonuniy vakillari yoki boshqa yaqin qarindoshlarining roziligi bilan u mobil shaklda palliativ yordam ko'rsatishga yo'naltirilishi mumkin.

Mazkur bandning "a" yoki "b" kichik bandlarida nazarda tutilgan mezonlarga mos bo'lmagan bolani hamda 18 yoshga to'lgan shaxsni Markazga qabul qilish rad etiladi.

Agarda bemor bola Markazda palliativ yordam olayotgan davrda 18 yoshga to'lib, unga konsilium tomonidan palliativ yordam ko'rsatish davom ettirish lozim deb topilgan holatlar bundan mustasno.

24. Quyidagi holatlar aniqlanganda bolaning klinik holati barqarorlashgunga qadar uni Markazga qabul qilish vaqtincha to'xtatiladi:

a) klinik holati intensiv terapiya, reanimatsiya tadbirlari talab etmaydigan, barqaror bo'lganda hamda holatning o'tkir og'irlashuvi belgilari mavjud bo'lmaganda, shu jumladan quyidagilardan kamida biri kuzatilganda:

o'tkir nafas olish buzilishlari;

gemodinamikaning beqarorligi;

faol qon ketishi;

shoshilinch ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni talab qiluvchi boshqa holatlar;

b) invaziv sun'iy o'pka ventilyatsiyasi, hayotiy muhim funksiyalarni ekstrakorporal qo'llab-quvvatlash yoki intensiv terapiyaning boshqa yuqori texnologiyali usullariga ehtiyoj bo'lganda;

d) yuqumli kasalliklar statsionarida davolanishni talab qiluvchi faol infeksiyon jarayon mavjud bo'lganda;

e) bolada boshqa tibbiy yordamga muhtojlik aniqlanganda.

Mazkur bandeda nazarda tutilgan holatlar aniqlanganda bolani davolash uchun bola tegishli tibbiyot muassasasiga yo'naltiriladi va ushbu holatlar bartaraf etilgandan keyin bolani Markazga qabul qilish konsilium tomonidan umumiy tartibda ko'rib chiqiladi.

25. Yo'llanmaga ega bo'lgan bemor bolalar konsilium tomonidan dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va uning natijalari bo'yicha bola Markazga bir kalendar yil davomida ko'pi bilan o'n to'rt kungacha vaqtincha, umrining oxirgi olti oyini yashayotganligi kutilayotgan hollarda muddatsiz qabul qilinadi.

Konsilium qarori bilan Markazga vaqtincha joylashtirilgan bolaning palliativ yordam xizmatidan foydalanish muddati uzaytirilishi mumkin. Bunda bolaning Markazda qolishining umumiy muddati yigirma sakkiz kundan oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi.

5-bob. Mobil shaklda palliativ yordam ko'rsatish tartibi

26. Mobil shakldagi palliativ yordam mobil brigada tomonidan Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hududida yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan bola va uning oilasiga uy sharoitida xizmat ko'rsatish va masofaviy (mobil aloqa yoki onlayn shaklda) maslahatlar berish orqali taqdim etiladi.

27. Markazda palliativ yordam bo'yicha shifokor, psixolog, ijtimoiy xodim va hamshiradan iborat tarkibda Markaz bosh shifokorining buyrug'i bilan mobil brigada guruhi tasdiqlanadi.

28. Mobil brigada faoliyatini tashkil etish uchun ikkita maxsus jihozlangan avtomobillar ajratiladi.

Zaruratga ko'ra Markazga Agentlik, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi o'zaro kelishuvi asosida qo'shimcha mobil brigadalar tashkil qilinishi mumkin.

29. Mobil brigada quyidagi vazifalarni bajaradi:

bola va uning oila a'zolariga palliativ yordam doirasida ko'rsatiladigan xizmatlarni aniqlash maqsadida kompleks baholashni amalga oshiradi;

bola uchun individual palliativ yordam ko'rsatish rejasini ishlab chiqadi;

bolada kechayotgan og'riqni nazorat qiladi;

kasallik belgilarini davolashni tashkil etadi;

bolaning oila a'zolariga parvarish qilish bo'yicha maslahatlar berib boradi;

bolaga va oilaga psixologik yordam ko'rsatadi;

bolani va uning oila a'zolarini ijtimoiy xizmatlarga yo'naltiradi;

oilaga a'zolariga konsultativ yordam ko'rsatadi;

uy sharoitida reabilitatsiya mashg'ulotlarini o'tkazadi;

palliativ yordam ko'rsatish uchun zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash choralarini ko'radi.

30. Mobil brigada tomonidan bolaning uy sharoitida palliativ yordam olishga muhtojlik darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining baholash uslubiyoti asosida baholashdan o'tkaziladi.

31. Bolaning uy sharoitida palliativ yordam olishga muhtojlik darajasi baholash natijalariga ko'ra haftalik uyga tashriflar soni quyidagicha belgilanadi:

15-20 ball to'planganda – bir marta;

21-24 ball to'planganda – ikki marta;

25 va undan yuqori ball to'planganda – uch marta.

Konsilium qarori bilan mazkur badda nazarda tutilgan tashriflar soniga bolaning sog'ligi holatidan kelib chiqib o'zgartirish kiritish mumkin.

32. Mobil brigada faoliyati, jumladan, bemorlarga tashrif vaqti va yo'nalishlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, chaqiruvlarni tezkor taqsimlash hamda xizmat ko'rsatish sifatini baholash xizmat avtomobillari yoki xodimlarning qo'l telefonlariga GPS qurilmasini o'rnatish orqali Markaz bosh hamshirasi tomonidan muvofiqlashtirilib boriladi.

33. Mobil shakldagi palliativ yordam, shu jumladan psixologik qo'llab-quvvatlash xizmati bolaga hayotining so'nggi kunlarigacha hamda uning oila a'zolariga bola vafot etgandan keyin uch oygacha ko'rsatib boriladi.

34. Markazdan chiqarilgandan yoki mobil palliativ yordam tugatilgandan so'ng bola yashash joyidagi oilaviy shifokor nazoratiga olinadi. Oilaviy shifokor Markaz mobil brigadasi bilan hamkorlikda bolaning keyingi kuzatuvi va zarurat tug'ilganda qayta yo'naltirilishini ta'minlaydi.

6-bob. Markazning moliya-xo'jalik faoliyati

35. Markazning xonalari texnika xavfsizligi qoidalari hamda sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq jihozlanadi.

36. Mobil brigada tomonidan palliativ yordam ko'rsatiladigan bemor bolalarga zarur jihozlar Markaz va bolaning qonuniy vakili o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida tekin foydalanish uchun taqdim etiladi.

Markaz faoliyatini moliyalashtirish O'zbekiston Respublikasining respublika budjetidan ajratiladigan mablag'lar, Ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi va Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi mablag'lari, jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari va qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga amalga oshiriladi.

Bunda, Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi mablag'lari hisobidan palliativ yordam doirasida ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar uchun Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi Kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadigan tartibga muvofiq moliyalashtiriladi.

37. Bemor bolalar va ularning qonuniy vakillari va oila a'zolari Markazda statsionar palliativ yordam olish davrida qonunchilik hujjatlari va sanitariya va gigiyena qoidalariga muvofiq bepul ovqat bilan ta'minlanadi.

Markaz xodimlari ish vaqtida qonunchilik hujjatlari va sanitariya va gigiyena qoidalariga muvofiq bir mahal Markazda bepul ovqat bilan ta'minlanadi.

38. Markazning namunaviy shtatlari Agentlik tomonidan Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan kelishgan holda tasdiqlanadi.

7-bob. Yakunlovchi qoidalar

39. Bemor bola Markazda statsionar davolanayotgan davrda 18 yoshga to'lganda palliativ yordam ko'rsatish konsilium tomonidan belgilangan muddatga qadar davom ettiriladi.

Bunda, Markazda bemor bolaga palliativ yordam ko'rsatish yoshi ko'pi bilan 21 yoshgacha etib belgilanadi.

40. Markazga joylashtirilgan bolada o'lim holati qayd etilganda u o'lim epikrizi rasmiylashtirilgan holda Markazdan chiqariladi. Bunda bolaning qonuniy vakillari tomonidan uning o'limi sabablari bo'yicha e'tiroz bildirilgan hollarda marhum Samarqand viloyat Bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasining Patologoanatomya va murdalarni saqlash bo'limiga yo'naltiriladi.

41. Mobil brigada guruhlarini o'z faoliyati yuzasidan Markaz bosh shifokori va tegishli bo'lim boshlig'iga oylik, choraklik va yillik hisobotlarini berib boradi.

42. Palliativ yordam ko'rsatiladigan bola va uning oilasiga tegishli ma'lumotlardan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etgan holda va palliativ yordam ko'rsatishni tashkil etish maqsadida foydalanishga yo'l qo'yiladi.

43. Markaz faoliyati ustidan nazorat Agentlik va uning huzuridagi Ijtimoiy inspeksiya tomonidan amalga oshiriladi.

44. Markaz xodimlari va unga joylashtirilgan yoki uning xizmatlaridan foydalanayotgan bemor bolalarning qonuniy vakillari o'rtasidagi munosabatlar ichki tartib-qoidalar bilan tartibga solinadi.

45. Bemor bolalarning qonuniy vakillari Markazga joylashtirish, tibbiy-ijtimoiy xizmatlardan foydalanish jarayonida Markaz xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda shikoyat qilishlari mumkin.

46. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradilar.

Palliativ yordam olish uchun asos bo'ladigan tibbiy ko'rsatmalar RO'YXATI

I. Asab tizimi kasalliklari.

1. Asab tizimining og'ir, surunkali, progressiyalanuvchi yoki qaytmas shikastlanishi bilan kechuvchi kasalliklari, shu jumladan:

- og'ir shakldagi bolalar serebral falaji;
- markaziy asab tizimining perinatal, gipoksik-ishemik va anoksik shikastlanishi oqibatlari;
- og'ir epileptik ensefalopatiyalar va farmakorezistent epilepsiya;
- progressiyalanuvchi neyrodegenerativ va demiyelinizatsiyalovchi kasalliklar;
- tug'ma nuqsonlar (jumladan og'ir gidrotsefaliya);
- og'ir bosh miya jarohati va neyroinfeksiyalar oqibatlari;
- boshqa og'ir nevrologik kasalliklar.

II. Progressiyalanuvchi nerv-mushak kasalliklari

2. Nerv-mushak tizimining og'ir, progressiyalanuvchi irsiy va orttirilgan kasalliklari, shu jumladan:

- spinal mushak atrofiyasi;
- mushak distrofiyalari;
- miopatiyalar;
- motor-sensor neyropatiyalar;
- tug'ma miastenik sindromlar;
- mitoxondrial va metabolik miopatiyalar;
- boshqa progressiyalanuvchi nerv-mushak kasalliklari.

III. Genetik, irsiy va orfan kasalliklar

3. Hayotni cheklovchi yoki hayot davomiyligini qisqartiruvchi og'ir genetik, irsiy, metabolik va orfan kasalliklar, shu jumladan:

- xromosoma kasalliklari;
- irsiy moddalar almashinuvi kasalliklari;
- lizosomal to'planish kasalliklari;
- mukopolisaxaridozlar;
- peroksisomal kasalliklar;
- mitoxondrial kasalliklar;

neyronal seroid lipofussinozlar;
organik atsidemiyalar va aminoatsidopatiyalar;
yog' kislotalari almashinuvi buzilishlari;
glikogenozlar;
tug'ma glikozillanish buzilishlari;
boshqa og'ir irsiy va orfan kasalliklar.

IV. Onkologik va onkogematologik kasalliklar

4. Palliativ yordam ko'rsatmalari mavjud bo'lgan barcha lokalizatsiyadagi yomon sifatli o'smalar;
5. Davolash prognozi manfiy bo'lgan qaytalanuvchi yomon sifatli o'smalar;
6. Palliativ yordam ko'rsatmalari mavjud bo'lgan miyelodisplastik va miyeloproliferativ kasalliklar;
7. Boshqa davolab bo'lmaydigan onkologik va onkogematologik kasalliklar.

**Bolalar uchun xospis markazi to'g'risida
vaqtinchalik nizomga
2-ILOVA**

BOLAGA PALLIATIV YORDAM KO'RSATISH UCHUN YO'LLANMA

Yo'llanma beruvchi tibbiyot muassasasi: _____

Yo'llanma raqami _____	Rasmiylashtirilgan sana: ____/____/20____
1. BOLA VA QONUNY VAKIL HAQIDA MA'LUMOT	
Bolaning F.I.Sh.: _____	
Tug'ilgan sana: ____/____/____ ☐ o'g'il bola ☐ qiz bola JShShIR: _____	
Shaxsini tasdiqlovchi hujjat: ☐ tug'ilganlik guvohnomasi ☐ pasport/ID; seriya va raqam: _____	
Yashash manzili: _____	
Qonuniy vakil F.I.Sh.: _____ Qarindoshligi: _____	
Tel.: _____	
2. KLINIK MA'LUMOT	
Asosiy tashxis va XKT-10 kodi: _____	

Asoratlari va hamroh kasalliklari: _____	

PaPaS bahosi: _____ ball Baholangan sana: ____/____/20____	
Konsilium xulosasi: № _____ sana ____/____/20____ Palliativ yordamga muvofiq: ☐ ha ☐ yo'q	
Yetakchi simptom/ehhtiyojlar: ☐ og'riq ☐ hansirash ☐ tirishish ☐ yutish/oziqlanish muammosi ☐ ko'ngil aynishi/qusish ☐ psixologik/ijtimoiy yordam ☐ boshqa: _____	
3. KLINIK MARSHRUT VA XIZMAT SHAKLI	
Palliativ yordam shakli: ☐ mobil (uy sharoitida) ☐ statsionar (xospis/bo'lim)	
Yo'naltirilayotgan xizmat/muassasa: _____	
Yo'naltirish sababi va birinchi navbatdagi vazifalar: _____	
Mobil xizmat belgilanganda zarur jihozlar: ☐ kislorod konsentratori ☐ aspirator ☐ nebulayzer ☐ pulsoksimetr ☐ funksional karavot ☐ antidekubit matras ☐ nogironlik aravachasi ☐ oziqlantirish/infuzion pompa ☐ boshqa: _____	
4. ILOVALAR VA TASDIQLASH	
Ilovalar: ☐ kasallik tarixidan ko'chirma — ____ varaq (majburiy) ☐ tekshiruv natijalari — ____ varaq	
Yo'naltiruvchi shifokor F.I.Sh.: _____ Lavozimi/tel.: _____ Imzo: _____ Sana: ____/____/20____	Bosh shifokor (o'rinbosari) F.I.Sh.: _____ Imzo: _____ M.O'.

Kiritildi:

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy
himoya milliy agentligi
direktorining o'rinbosari



J. Abruyev

“ ” _____ 2026-yil
№

Kelishilgan:

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vaziri



E. Adilov

“30” iyul 2026-yil
№ 04-QQ

O'zbekiston Respublikasi
Iqtisodiyot va moliya
vazirining o'rinbosari



O. Fazilkarimov

“30” iyul 2026-yil
№ 15-QQ

